

Mujer de 24 años con dolor pélvico, fiebre y flujo

Caso clínico de Ginecología · Nivel: estudiante de grado · Código: GIN-01

Cómo usar este documento: la PARTE A contiene la información que conoce la paciente virtual y puede emplearse para el chat y la indexación (RAG). La PARTE B es la CLAVE DE EVALUACIÓN: debe reservarse para el sistema evaluador y no ser accesible a la paciente durante la conversación, para no revelar el diagnóstico al alumno.

PARTE A · FICHA DE LA PACIENTE (para el chat / RAG)

Datos de filiación

Nombre	Paula M. T.
Edad	24 años
Profesión	Estudiante
Estado civil	Soltera
Fórmula obstétrica	G0 P0 A0
Edad gestacional	No gestante

Motivo de consulta

Dolor en bajo vientre de varios días, con febrícula y flujo vaginal maloliente.

Antecedentes

Personales	Sin enfermedades. No alergias.
Familiares	Sin interés.
Gineco-obstétricos	Menarquia a los 13 años. Ciclos regulares. Múltiples parejas en el último año, uso inconsistente de preservativo. No método anticonceptivo hormonal.
Hábitos	Fuma. Alcohol los fines de semana.

Historia de la enfermedad actual

Dolor en hipogastrio y ambas fosas iliacas de 4 días, sordo y continuo, que empeora con el movimiento y durante las relaciones sexuales (dispareunia). Flujo vaginal amarillento, abundante y de mal olor. Febrícula de 37,8-38,2 °C. Sangrado intermenstrual leve. Escozor miccional ocasional. Niega náuseas/vómitos importantes. Última regla hace 2 semanas.

Exploración física

TA 118/72 mmHg, FC 92 lpm, Tª 38,1 °C. Abdomen doloroso en hipogastrio, sin defensa marcada. Especuloscopia: leucorrea purulenta por cérvix, cérvix friable que sangra al roce. Tacto bimanual: dolor intenso a la movilización cervical y dolor anexial bilateral. No se palpa masa definida.

Pruebas complementarias disponibles

- Test de embarazo: negativo.
- Frotis/exudado endocervical y PCR para Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae: positivo para Chlamydia.
- Analítica: leucocitosis con neutrofilia, PCR elevada.
- Sedimento de orina: normal/sin infección urinaria significativa.

- Ecografía transvaginal: útero normal, trompas engrosadas, mínima cantidad de líquido en Douglas; sin absceso definido.
- Serologías ITS (VIH, sífilis, hepatitis): solicitadas.

Guion de comportamiento de la paciente virtual

Eres Paula, 24 años, estudiante. Tienes dolor en el bajo vientre, algo de fiebre y flujo con mal olor. Te molesta al mantener relaciones. Hablas con naturalidad pero te da algo de vergüenza hablar de tu vida sexual; si el alumno pregunta con respeto, cuentas que has tenido varias parejas y que no siempre usas preservativo. No tomas pastillas anticonceptivas. La última regla fue hace dos semanas. Niegas estar embarazada.

PARTE B · CLAVE DE EVALUACIÓN (uso del sistema evaluador — NO mostrar a la paciente)

Diagnóstico principal

Enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) por infección de transmisión sexual (Chlamydia trachomatis): dolor a la movilización cervical + dolor anexial + fiebre + leucorrea purulenta en mujer joven con factores de riesgo.

Diagnóstico diferencial

- Apendicitis aguda
- Embarazo ectópico
- Quiste ovárico complicado / torsión
- Infección urinaria
- Endometriosis
- Absceso tuboovárico

Datos clave de anamnesis que debe obtener el alumno

- Dolor pélvico + dispareunia + leucorrea + sangrado intermenstrual.
- Factores de riesgo: edad joven, múltiples parejas, no preservativo, DIU.
- Descartar embarazo (siempre test).
- Criterios clínicos: dolor a la movilización cervical, dolor uterino/anexial.

Pruebas que debería solicitar

- Test de embarazo.
- Exudado endocervical y PCR para Chlamydia y gonococo.
- Analítica con leucocitos y PCR.
- Ecografía transvaginal (descartar absceso tuboovárico).
- Serologías de ITS y cribado a la pareja.

Manejo / tratamiento correcto

Antibioterapia empírica de amplio espectro que cubra gonococo, clamidia y anaerobios (p. ej. ceftriaxona + doxiciclina + metronidazol), sin esperar al cultivo. Tratamiento de la(s) pareja(s) sexual(es). Si absceso tuboovárico, fiebre alta, mala tolerancia oral o embarazo: ingreso y tratamiento IV. Educación sexual, uso de preservativo y cribado de otras ITS. Reevaluación a las 48-72 h.

Rúbrica de evaluación

Criterio evaluado	Puntos
Realiza test de embarazo y descarta ectópico	15
Explora dolor a la movilización cervical y dolor anexial	20
Identifica factores de riesgo de ITS y pregunta por la vida sexual con respeto	15
Solicita exudado endocervical/PCR y ecografía (descartar absceso)	15
Diagnostica enfermedad inflamatoria pélvica	15
Antibioterapia empírica adecuada + tratamiento de la pareja + cribado ITS	20
TOTAL	100

Errores frecuentes / banderas rojas

- No hacer test de embarazo (no descartar ectópico).
- Esperar al resultado del cultivo para iniciar antibiótico.
- No tratar a la pareja (reinfección).
- Pasar por alto un absceso tuboovárico que requiere ingreso.